The picture can't be displayed.

PERCORSO PSICOEDUCATIVO

ANSIA NON TI TEMO

«Le tecniche di gestione dell'ansia»

Dott.ssa Mariachiara Di Francesco

Psicologa – Psicoterapeuta – Esperta in Neuropsicologia

ATTIVAZIONE EMOTIVA

Mi ascolto e con una parola provo a dire come mi sento in questo momento…

PRIMO INCONTRO

L’emozione ansia

L’ansia è un’emozione che coinvolge **aspetti fisiologici** (tachicardia, sudorazione, vertigini…), **cognitivi** (scarsa memoria, distraibilità, paura di perdere il controllo, di sentirsi male e di impazzire…), **comportamentali** (attacco, fuga, evitamento…) ed **emotivi** (agitazione, angoscia, tensione, paura…) del funzionamento degli esseri umani. (Clark e Beck, 2010).

L’ansia è un’emozione che viene definita secondaria o complessa!

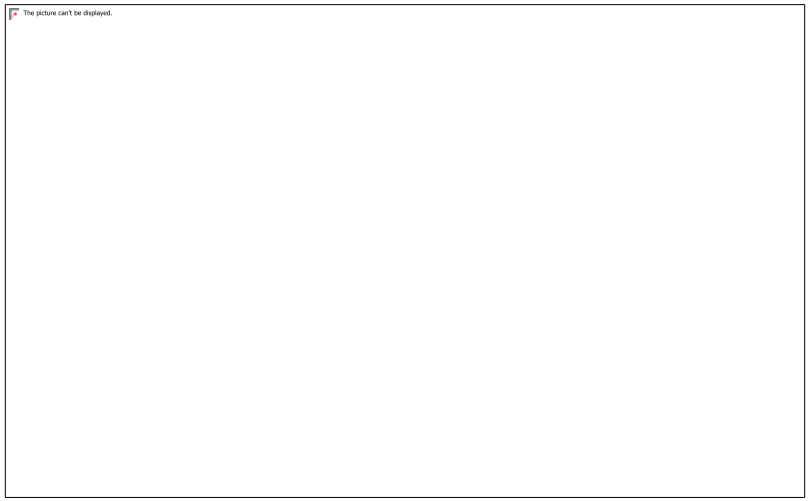
Non è dunque un’emozione primaria e, in quanto tale, non è presente dalla nascita e non è tipica di tutte le culture.

Tra le emozioni primarie troviamo:

Felicità – Tristezza – Rabbia – Paura – Disgusto - Sorpresa

The picture can't be displayed.

Le emozioni primarie si provano sin dai primi giorni di vita e sono presenti in tutte le popolazioni e negli animali.



L’ansia è, invece, un’emozione appresa nel corso della vita attraverso gli eventi che ci capitano e con gli scambi relazionali ai quali siamo esposti.

Insieme all’ansia, tra le emozioni secondarie,

troviamo invidia, vergogna, colpa, gelosia.

Queste emozioni sono molto più complesse, perché derivano dalle emozioni primarie e sono apprese attraverso la storia personale di ogni persona (Fiore, 2015).

L’ansia non è, quindi, una malattia ma un’emozione: un segnale che ci rimanda a significati personali da conoscere e da gestire.

L’ansia viene, inoltre, vista come l’anticipazione di uno scenario catastrofico futuro, non certo.

Da un punto di vista antropologico essa, insieme alla paura, ha da sempre permesso la sopravvivenza degli individui di fronte a situazioni pericolose per sé e per la specie ed è da considerarsi assolutamente funzionale all’esistenza.

Un’eliminazione totale non è né possibile né auspicabile!

Solo quando essa supera una determinata soglia, allora può essere considerata disfunzionale poiché diventa invalidante ed ostacolante per la persona che la prova, conducendo, talvolta, a forme psicopatologiche.

“Di notte improvvisamente mi sono svegliata, mi mancava il respiro, mi sentivo soffocare. Dovevo prendere assolutamente ossigeno e sono corsa fuori… Ma la situazione non si è calmata, anzi peggiorava sempre più. Mi mancava il fiato, sentivo un dolore al petto e ho pensato che stessi per morire”.

Incontro 1: L’emozione ansia

L'ansia è un segnale d'allarme che si attiva per anticipare un potenziale pericolo, cioè per mettere in guardia la persona, dandole la possibilità di reagire con modalità che possano evitare la situazione rischiosa.

Questo vale sia che ci si trovi di fronte ad un pericolo reale (ad esempio un auto che sta per investirci) sia che ci si trovi di fronte ad un pericolo immaginato e legato a esperienze negative passate (ad esempio aver subito uno scippo, potrà suscitare ansia tutte le volte che si sentirà il motore di uno scooter).

Da ciò deriva che si può parlare di *un’ansia sana e funzionale*, che ci permette di mettere in atto una risposta utile, probabilmente di attacco o fuga, e di *un’ansia disfunzionale* che si attiva, a volte sulla base di un ricordo traumatico, quando il pericolo e la minaccia non sono reali ma solo immaginati.

CHE DIFFERENZA C’E’ TRA ANSIA E PAURA?

È importante fare una prima distinzione tra paura ed ansia.

La paura è un’emozione che ci avverte della presenza di un pericolo imminente, come ad esempio qualcuno che ci rincorre con un coltello in mano, intenzionato a farci del male.

In questo caso la rappresentazione del pericolo è ben definita nella mente del soggetto che la prova.

Nell’ansia invece, la rappresentazione minacciosa non è delineata, è un’emozione che nasce dall’anticipazione di uno scenario catastrofico futuro, non certo.

Solitamente, l’ansia è mantenuta da pensieri negativi posti in forma di molti “e se…”, dubbi che generano malessere nell’individuo che se li pone (American Psychiatric Association [APA], 2014).

L’ansia e la paura sono due emozioni simili nella loro manifestazione fisiologica (attraverso sintomi fisici quali tachicardia, respirazione affannosa, sudorazione, senso di nodo alla gola, ecc.), entrambe sono la reazione ad una minaccia ma differiscono sostanzialmente perché:

- la **paura** è una reazione emotiva ad un pericolo reale.
- l’**ansia** è una reazione emotiva ad un pericolo percepito.

Le reazioni di paura sono intense, il livello di attivazione si innalza improvvisamente, c’è un carattere di emergenza di fronte a un oggetto specifico, l’attivazione è episodica e cessa quando il pericolo si allontana.

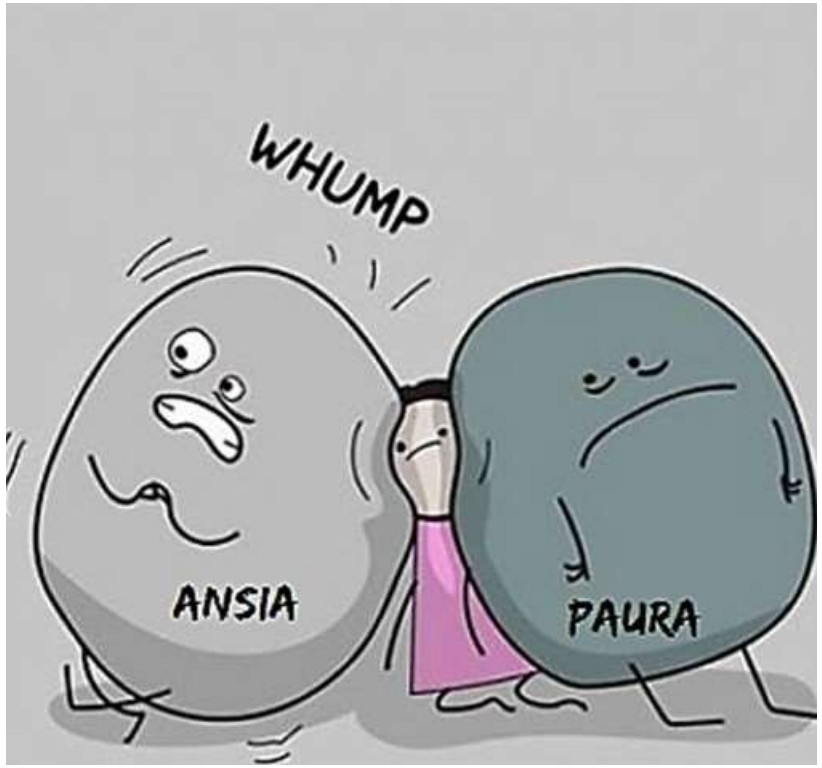
Nel caso dell’ansia, la minaccia è meno evidente, il disagio è più prolungato e sia l’esordio che la fine sono meno netti. L’ansia è meno intensa e si configura come una sensazione di tensione da aumentata vigilanza.

Dunque, una differenza fondamentale sta nella consistenza della minaccia: quanto più la minaccia è definita tanto più si parla di paura, mentre quanto più è indefinita tanto più si parla di ansia.

Inoltre, per sperimentare ansia è necessario un sistema cognitivo più complesso che possa prevedere le conseguenze a medio e lungo termine e che sia in grado di compiere ragionamenti ipotetici, mentre ciò non è necessario per la paura.

Per provare quest’emozione è necessario quello che Damasio chiama il «*Sé autobiografico*» che genera la coscienza estesa, la quale consiste nella percezione di una estensione di sé nel passato e nel futuro e dunque di una unicità nella continuità del cambiamento vitale.

Per questi motivi, l’ansia può essere definita la «*sorella evoluta della paura*».



SVANTAGGI DELL’ANSIA

Uno degli aspetti più disadattativi dell’ansia è che la maggior parte dei pericoli situati nel futuro, per i quali si sperimenta ansia, non sono granchè modificabili e dunque il fatto di preoccuparsene non diminuisce la possibilità che essi si realizzino.

SVANTAGGI DELL’ANSIA

L’altro aspetto disadattivo consiste nel fatto che seppure è utile predisporre rimedi per eventi temuti che si collocano nel futuro non serve certamente l’attivazione ansiosa e corporea che, invece, si dimostra tanto utile nella paura e nella conseguente allerta.

L’ansia ed i suoi effetti possono essere concepiti come una curva che ne rappresenta la soglia di severità.

Un’ansia sana, non patologica, aiuta nelle prestazioni, spinge all’azione. Se non provassimo mai ansia (ad esempio prima di un compito in classe o prima di una gara sportiva), probabilmente ne risentirebbe anche la nostra prestazione.

Una buona quota di ansia, infatti, è utile per motivarci, spinge all’azione e migliora le prestazioni.

Ma se la curva dell’ansia si alza ulteriormente, in modo eccessivo, essa non è più un’emozione adattiva, funzionale alla prestazione, perché compromette l’attività in cui il soggetto deve cimentarsi.

L’ansia, diventa disfunzionale per la persona quando reca disagio a chi la prova, in particolare se si presenta in momenti in cui non occorre e si presenta con costanza ed intensità tali da andare a peggiorare la condizione di vita e le attività di della soggetto (Barnhill, 2020).

Legge di Yerkes-Dodson

Sviluppata nel 1908 dagli psicologi Robert M. Yerkes e John Dillingham Dodson, la *legge di Yerkes e Dodson* sostiene che il rendimento aumenti con l’eccitazione fisiologica o mentale, ma solo fino a un certo punto.

Quando i livelli di eccitazione diventano troppo alti, il rendimento diminuisce.

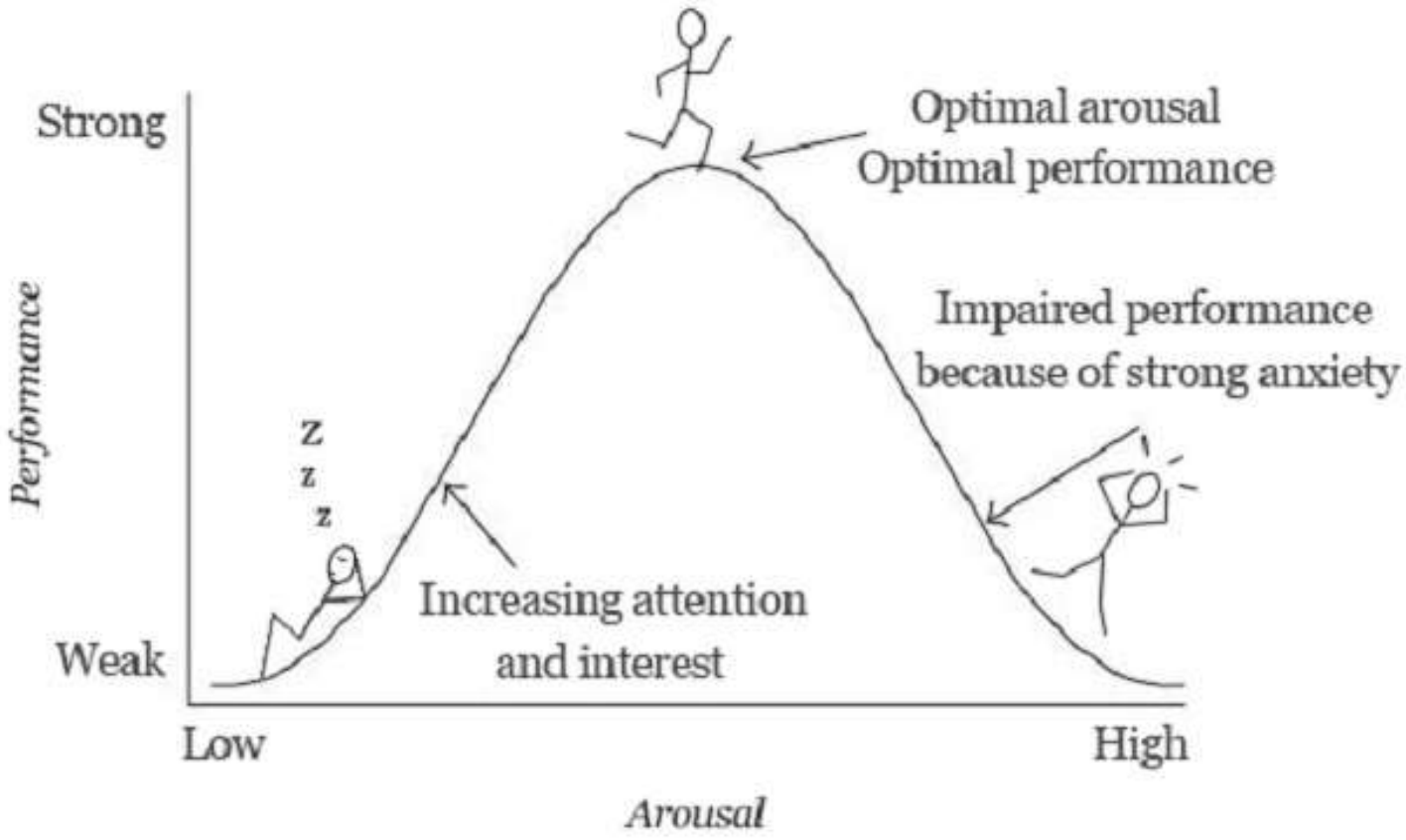
Legge di Yerkes-Dodson

Un esempio del funzionamento di questa legge è l’ansia che si prova prima di un esame. Un livello ottimale di stress può aiutare a concentrarsi nella prova e a ricordare le informazioni. Quando l’ansia è troppa, però, può compromettere la capacità di concentrazione, rendendo più difficile ricordare i concetti.

Legge di Yerkes-Dodson

Un altro esempio della legge di Yerkes-Dodson è il rendimento sportivo. Quando un atleta è sul punto di fare una mossa importante, un livello ideale di eccitazione, secrezione di adrenalina, può potenziare il suo rendimento e permettergli di agire al meglio. Se è troppo stressato, potrebbe andare in tilt e fare la sua mossa in maniera poco energica o precisa.

Incontro 1: L’emozione ansia



L’ansia è un segnale che la nostra mente ci invia sottoforma di diversi sintomi - cognitivi, comportamentali, emotivi e corporei – e, per questo, rappresenta un campanello d’allarme proprio come quando il nostro corpo subisce un innalzamento della temperatura corporea e ci viene la febbre.

A cosa è dovuta quella febbre?

È importante conoscerne la giusta causa per un trattamento efficace!

È fondamentale chiedersi cosa ci vuole dire questa ansia: probabilmente, ci avverte di qualcosa che non sta andando nella nostra vita prima ancora che noi ne siamo consapevoli o capaci di verbalizzarlo; il corpo parla per noi.

Il sintomo rappresenta il non espresso.

Tutto ciò è importante per imparare poi a gestirla e, nel lungo termine, provare a prevenirne le recidive.

NORMALIZZIAMO L’ANSIA:

È NORMALE PROVARE ANSIA!!!

Per evitare che essa raggiunga un’alta intensità che potrebbe, poi, diventare invalidante.

CHE COS’E’ CHE SPAVENTA?

George Kelly sosteneva che è minaccioso ciò che appare imprevedibile.

L’ansia è il segnale che ci si trova a fronteggiare eventi che cadono al di fuori del campo di applicabilità del proprio sistema di costrutti.

Ciò che non si conosce è spaventoso proprio in quanto imprevedibile e come tale incontrollabile.

CHE COS’E’ CHE SPAVENTA?

Inoltre, un evento può essere sperimentato come minaccioso se pensiamo di non avere su di esso alcun potere, se riteniamo di non poterlo controllare, pur conoscendolo e prevedendolo.

Ciò che, infine, spaventa è l’esito finale: come sarò dopo che tutto ciò sarà successo.

Questo futuro stato del Sé è poco costruito, immaginato, sfuocato e incerto e per questo spaventoso.

COME INSORGE L’ANSIA?

L’ORIGINE DI QUESTA EMOZIONE

Secondo un noto psicoterapeuta americano di nome Albert Ellis, all’origine dell’ansia, ci sarebbero una serie di pensieri, che egli definisce disfunzionali, appartenenti alle seguenti categorie:

- Doverizzazioni o pretese («Io devo fare», «tu devi fare», «gli altri e il mondo devono fare»;
- Generalizzazioni e assolutismi;
- Catastrofizzazioni o terribilizzazioni;
- Intolleranza alla frustrazione.

DOVERIZZAZIONI O PRETESE

«Alla base dei disturbi emotivi ci sono delle credenze imperative che l’universo debba procedere in un determinato modo»

DOVERIZZAZIONI O PRETESE

Le pretese (*demands*) riflettono aspettative assolute e irrealistiche su eventi o individui e sono spesso riconoscibili da parole-segnale come «*devo*», «*devi*», «*bisogna*», «*è necessario*».

Le persone si formano degli schemi sulla realtà che le circonda.

Diversi studi hanno dimostrato che quando percepiamo una discrepanza fra il nostro schema del mondo e la realtà con cui ci confrontiamo, si genera uno stato di attivazione emotiva.

DOVERIZZAZIONI O PRETESE

La rigidità e l’incapacità di modificare i propri schemi sono tra le cause principali dei disturbi che affliggono il genere umano.

TERRIBILIZZAZIONI

La terribilizzazione (*awfulizing*) o catastrofizzazione (*catastrophizing*) è una forma di pensiero caratterizzata da valutazioni eccessivamente negative su un aspetto di noi stessi, degli altri o della vita in generale.

Porta spesso a fare previsioni eccessivamente negative, e non basate sui fatti, sulle conseguenze di una situazione.

«Ho sofferto di molte disgrazie nella mia vita. La maggior parte di queste non è mai accaduta»

Mark Twain

TERRIBILIZZAZIONI

La modalità di pensiero tipicamente più associata ai disturbi d’ansia è proprio la terribilizzazione!

Spesso, è presente un mix di terribilizzazione e pretese:

«E’ terribile che al ristorante non abbiano il mio piatto preferito, dovrebbero averlo!»

INTOLLERANZA ALLA FRUSTRAZIONE

Secondo Ellis, gli esseri umani monitorano cognitivamente quanta frustrazione e sofferenza possono e sono disposti a sopportare.

Nutriamo delle aspettative sulla nostra forza o capacità di superare le difficoltà.

INTOLLERANZA ALLA FRUSTRAZIONE

Le persone svilupperebbero un’ansia rispetto ad una possibile sofferenza o disagio, associata a pensieri di questo tipo, che le convincono di non poter sopportare qualcosa che trovano frustrante o di non avere la forza di sopravvivere a un’evenienza del genere.

INTOLLERANZA ALLA FRUSTRAZIONE

Questi pensieri sono definiti illogici o disfunzionali perché, a meno di morire, si riesce, nella maggior parte dei casi, a tollerare ciò che si dichiara intollerabile.

INTOLLERANZA ALLA FRUSTRAZIONE

Harrington (2005) ha elaborato una scala che individua 4 tipi di intolleranza alla frustrazione:

- Intolleranza alle emozioni: incapacità di sopportare la sofferenza emotiva;
- Intolleranza alle ingiustizie: indisponibilità a tollerare le ingiustizie e il differimento di quelli che si percepiscono come propri diritti;
- Intolleranza agli insuccessi: senso di frustrazione che si sperimenta quando fallisce uno scopo;
- Intolleranza ai disagi: idea che la vita dovrebbe essere facile, comoda e priva di seccature.

INTOLLERANZA ALLA FRUSTRAZIONE

Secondo uno studio, la tipologia di intolleranza che più frequentemente genera ansia è l’intolleranza emotiva!

GENERALIZZAZIONI E ASSOLUTISMI

Valutazione globale del valore delle persone e delle cose

La tendenza a valutare globalmente, in modo negativo, il valore delle persone può sfociare in depressione o senso di colpa se la valutazione è riferita a noi stessi o in rabbia e disprezzo se riferita agli altri.

GENERALIZZAZIONI E ASSOLUTISMI

Valutazione globale del valore delle persone e delle cose

È importante giudicare le nostre azioni e non noi stessi.

«Sono andato male all’esame» non significa «sono un fallito».

«Odia il peccato, ma non il peccatore»

M. Gandhi

«Non dovremmo giudicare noi stessi ma accettarci in maniera incondizionata»

A. Ellis

È importante, quindi, provare ad individuare i pensieri antecedenti alla reazione emotiva «ansia» e, con un lavoro strutturato e specifico (CBT), provare a modificarli o «ristrutturarli» (*ristrutturazione cognitiva*) con l’obiettivo di generare credenze che possano essere definite razionali.

Una credenza razionale è:

- Coerente: segue logicamente le proprie premesse;
- Verificabile sul piano empirico: si possono portare delle prove a suo sostegno;
- Non è immutabile e assoluta;
- Suscita emozioni adattive: comprese emozioni negative di ogni grado d’intensità ma sane, funzionali e utili per affrontare situazioni;
- Ci aiutano a raggiungere i nostri scopi senza un livello eccessivo di attivazione.

Incontro 1: L’emozione ansia

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!

Dott.ssa Mariachiara Di Francesco

Psicologa – Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

Esperta in Neuropsicologia

mariachiaradifrancesco@yahoo.it